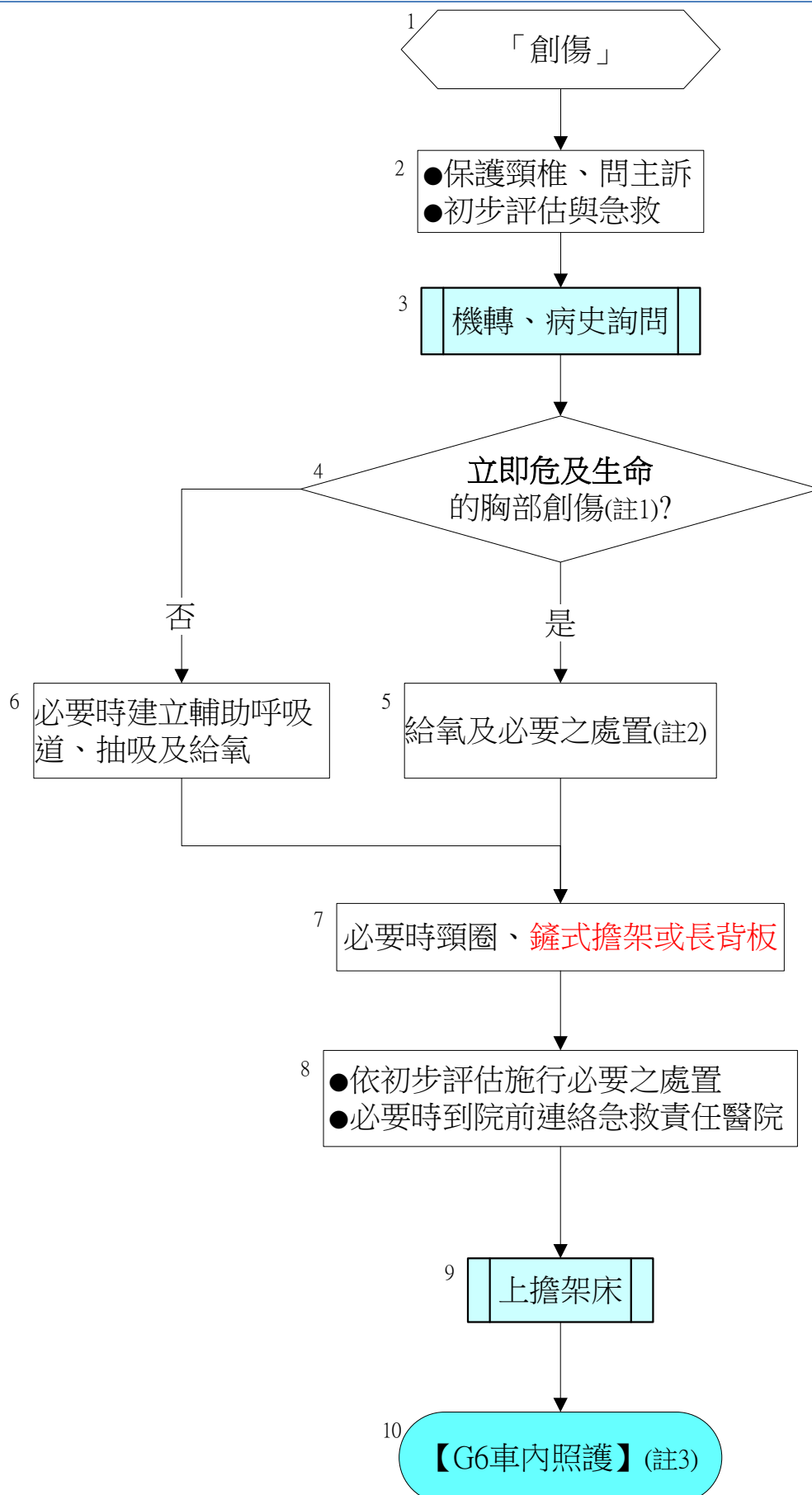


T3 胸部外傷

程 序



要 旨

- 一、EMT到達現場時應立即進行的評估及處置包括維持呼吸道暢通，保護頸椎，給予氧氣，評估氣管、頸靜脈及胸部狀況。儘量從受傷機轉與傷患評估中，找出危及生命的胸部外傷，並予以適當處置，以避免這類傷患可能在到院前發生心跳停止。
- 二、用各種氧氣治療的方式維持 $SpO_2 \geq 94\%$ ，並適當處置後立即送醫。
- 三、儘可能確認氣管支氣管斷裂、呼吸道阻塞、心包膜填塞、大量血胸、張力性氣胸及開放性氣胸等致命性胸部外傷，給予靜脈輸液；同時確認受傷機轉等資訊，聯絡轉送醫院。

註 解

註1>

立即危及生命的胸部外傷有氣管支氣管斷裂、呼吸道阻塞、心包膜填塞、大量血胸、張力性氣胸及開放性氣胸等6項。

註2>

- 一、立即危急生命的胸部外傷及急救處置：請注意本表所列六種外傷，傷患隨時可能進入PEA 而需要 CPR：

傷 勢	氣管支氣管斷裂	呼吸道阻塞	心包膜填塞	大量血胸	開放性氣胸	張力性氣胸
傷患評估可能發現	呼吸窘迫、發紺、血氧下降、咳血、皮下氣腫、張力性氣胸、縱隔腔移位	呼吸窘迫、發紺、血氧下降、上呼吸道有嘯鳴音（stridor）	前胸傷勢、血壓下降、頸靜脈鼓張、休克徵候、脈搏忽強忽弱（奇異式脈搏）、聽診心音遙遠模糊	呼吸窘迫、發紺、血壓下降、血氧下降、患側呼吸音減少且叩診實音	呼吸窘迫、發紺、胸壁不對稱起伏、穿刺傷致胸部開放性傷口、隨呼吸可感受到氣體進出	呼吸窘迫、發紺、血壓下降、氣管偏移、頸靜脈鼓張、血氧下降、患側呼吸音消失且叩診鼓音
救護處置	保持呼吸道通暢，給予高濃度氧氣	保持呼吸道通暢，並嘗試移除異物。	快速靜脈輸液，保持呼吸道暢通及維持適當血氧值。	快速靜脈輸液，改善休克狀態，並注意給氧等級，維持適當血氧值。	用無菌性不透氣敷料，覆蓋傷口固定其中3側。	P 符合針刺減壓條件時（同時出現呼吸窘迫、患側呼吸音消失、收縮壓 <90 mmHg）

- 二、針刺減壓法：大口徑針頭由腋前線及第5肋間交叉點(優先考慮位置)，或鎖骨正中線及第2肋間交叉點。消毒後針尖沿肋骨上緣插入減壓，並重新評估狀況是否改善)

註3>

一、次級評估時應考慮有無潛在危及生命的胸部外傷：

- (一) 縱膈穿透傷
- (二) 橫膈破裂
- (三) 主動脈破裂
- (四) 心臟挫傷
- (五) 肺挫傷
- (六) 單純氣胸
- (七) 血胸

二、因這些傷勢也許在到院前不易區分，EMT急救處置皆以下列原則進行：

- (一) 保持氣道通暢，並利用各種方式維持傷患適當血氧值。
- (二) 校正休克現象。
- (三) 立即轉送醫院。